

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re A

Amélioration de la santé reproductive

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Ce travail dirigé évalue votre capacité à mobiliser vos connaissances sur la santé reproductive pour analyser des situations concrètes et proposer des comportements responsables.

EXERCICE 1 Puberté et maturité reproductive

Dans un lycée de Yaoundé, une infirmière scolaire reçoit une élève de 15 ans, Amina, inquiète car elle n'a pas encore eu ses premières règles, alors que plusieurs de ses camarades sont déjà réglées depuis plus de deux ans. Amina pratique la danse classique de manière intensive (15 h/semaine) et présente un indice de masse corporelle (IMC) de 16,5 kg/m².

1. Rappeler les deux critères biologiques majeurs qui définissent la puberté chez la jeune fille et préciser l'âge moyen de leur survenue.
2. À partir du cas d'Amina, identifier deux facteurs environnementaux ou comportementaux susceptibles de retarder l'installation de la fonction reproductive.
3. Expliquer le mécanisme physiologique par lequel un faible tissu adipeux peut inhiber l'axe gonadotrope hypophysaire.

EXERCICE 2 Grossesse précoce : analyse épidémiologique

Le tableau ci-dessous présente des données issues de l'Enquête Démographique et de Santé (EDS) du Cameroun concernant la fécondité des adolescentes (15–19 ans) selon le milieu de résidence et le niveau d'instruction.

Caractéristique	% ayant commencé la vie reproductive	% mères	% enceintes 1er enfant	Âge médian 1er rapport
Urbain	24,5	18,2	6,3	18,2 ans
Rural	42,1	34,7	7,4	16,5 ans
Aucune instruction	58,3	49,1	9,2	15,8 ans
Secondaire +	15,6	10,4	5,2	19,1 ans

1. Construire un histogramme groupé comparant le pourcentage de jeunes filles ayant « commencé la vie reproductive » selon le milieu de résidence et le niveau d'instruction (deux séries de barres).
2. Analyser l'influence du niveau d'instruction et du milieu de résidence sur la précocité

de la vie reproductive. Justifier votre réponse par des valeurs du tableau.

3. Citer trois conséquences médico-sociales spécifiques d'une grossesse survenue avant 18 ans pour la mère et pour le nouveau-né.

EXERCICE 3 IST et stratégies de prévention

Lors d'une campagne de dépistage volontaire dans un centre de santé de Douala, sur 200 jeunes de 15–24 ans testés, 18 sont séropositifs pour le VIH, 22 présentent une infection à *Chlamydia trachomatis* et 15 une infection à *Neisseria gonorrhoeae*. Parmi les infectés par le VIH, 60 % ignoraient leur statut.

1. Calculer la prévalence globale des IST dépistées dans cet échantillon. Exprimer le résultat en pour mille (‰).
2. Classer le VIH, *Chlamydia trachomatis* et *Neisseria gonorrhoeae* selon leur agent pathogène (virus, bactérie, parasite) et leur mode de transmission principal.
3. Justifier, sur le plan physiopathologique, pourquoi la présence d'une IST ulcéreuse (comme la syphilis ou le chancroïde) ou inflammatoire augmente le risque de transmission sexuelle du VIH.
4. Proposer une stratégie de prévention combinée (biomédicale, comportementale, structurelle) adaptée à cette population jeune, en citant un exemple concret par volet.

EXERCICE 4 Planification familiale : étude de cas

Marie, 22 ans, étudiante en Première année à l'Université de Ngaoundéré, consulte au Centre de Santé Universitaire pour une contraception. Elle a un rapport sexuel régulier avec son petit ami. Elle refuse toute méthode contenant des œstrogènes (antécédent familial de thrombose veineuse profonde chez sa mère). Elle souhaite une méthode « oubliable », efficace, et ne désirant pas d'enfant avant 3 ans.

1. Parmi les méthodes suivantes (pilule microprogestative, implant sous-cutané, DIU au cuivre, préservatif masculin, stérilisation tubaire), sélectionner les deux méthodes les plus adaptées au profil médical et au projet de vie de Marie. Justifier chaque choix par un argument médical et un argument pratique.
2. Expliquer le mécanisme d'action contraceptif principal de l'implant sous-cutané (etonogestrel) et du DIU au cuivre.
3. L'infirmière lui remet un préservatif masculin en complément. Justifier cette double protection (double méthode) en citant les deux protections distinctes apportées.

EXERCICE 5 Comportement responsable et prise de décision

Paul, 17 ans, élève en Première A, apprend que sa petite amie Chantal, 16 ans, est enceinte de 8 semaines. Ils sont tous les deux scolarisés, non mariés, et n'avaient pas utilisé de contraception. Paul propose à Chantal de recourir à un avortement clandestin pratiqué par une « sage-femme traditionnelle » du quartier pour « ne pas gâcher leur avenir ».

1. Rappeler le cadre légal de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) au Cameroun (Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016, Code pénal).
2. Identifier et expliquer trois risques majeurs (médicaux, juridiques, psychosociaux) encourus par Chantal et Paul en cas de recours à un avortement clandestin.
3. En tant que pair éducateur, formuler un argumentaire structuré (3 arguments) pour convaincre Paul d'adopter un comportement responsable : accompagnement de Chantal vers une structure de santé qualifiée, poursuite de la scolarisation, et prévention d'une récurrence.